EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88580
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-15 09:17:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ALICIA RIVERA LAGUNA			RUN	: 8.359.368-7
F.Nac	: 22-08-1929	Edad	: 94 AÑOS, 10 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: CACHAPOAL			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 987238226		
Fecha Ingreso	: 2024-07-13	Fecha Egreso	: 2024-07-15 09:17:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I21.9-INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Neumonía bilateral en Resolución
Infarto Agudo Al Miocardio
Enfermedad Coronaria Moderada Derecha Media (40%)
ICC descompensada Resuelta
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente de 94 años, usuaria de sillas de ruedas, con antecedentes de HTA en tto, sin alergias conocidas. Paciente traída por familiares.
Acorde a relato de familiar disponible durante momento de valoración dirigida, paciente inicia con sintomatología hace al menos 3 días preentando accesos de tos intermitente leve a moderada, humeda, expectoración no efectiva, asociado a dolor abdominal generalizado leve y vómitos.
Acuden en primera instancia a centro APS donde se trata como patología abdominal leve, brindando tratamiento EV con pargeverina + metamizol, derivando a domicilio.
Para hoy 13/07, cuadro se exacerba al menos 1 hora previo a ingreso, anexándose dolor torácico y palpitaciones. Ingresa a servicio de urgencias con SV en rango, con FC 115 lpm, SV 110/68mmHg.
Exámenes de laboratorio reportan: Gli: 195* | Alb: 4,1 | Crea: 1,10* | FA: 126 | Bl: 0,68 | BD: 0,12 | BT: 0,80 | ASAT: 99* | ALAT: 33 | GGT: 38 | CK-MB: 57* | CK: 586* | Chol: 219* | HDL: 100 | LDL: 102 | VLDL: 17,20 | Lip: 55 | MDRD: 46,25 | Lact: 2,9* | CRP: 76,1* | Uremia: 63* | Na: 139,00 | K: 4,20 | Cl: 106,00 | Hb: 12,4 | HTO: 37,7 | GB: 18,20* | Plt: 266 | Segm: 88* | Linf: 5* | Mono: 6 | Eos: 0 | Bas: 1 | INR: 1,08 | PT: 88% | PT(sec): 14,5 | TTPA: 25* | Trop: 7307,8*
Se solicita dimero D que además está aprox 4000.
Se indica AngioTC que reporta: Signos de neumopatía aguda multifocal. Aumento de densidad en vidrio esmerilado en segmentos posteriores de ambos lobulos superiores e inferiores, y zona de consolidación atelectásica en LII. Derrame pleural leve.
Se presenta caso a HLH en vista de valores de troponinas elevados. Acude a coronariografía donde, acorde a registro, paciente se hipotensa y desorienta, por lo que deciden medidas de soporte con atropina 0.3mg ev y suspender procedimiento, recomendando tratamiento médico.
En vista de condición actual y fragilidad de paciente, teniendo en cuenta que condición basal previa estaba limitada siendo dependiente moderada, se conversa caso con familiares para acordar AET.
Ex físico; Piel: cambios y signos propios de la edad. Buen llenado capilar.
CP: Torax asimétrico, prominencias óseas +++, WOB++, RSRSPS estertores y crepitos bibasales, RSCSASIS

destaca soplo holosistólico de alta intensidad Abd: RHA+, no impresionan megalias. BDI
Neurológico: consciente, orientada en espacio y persona, sin signos de focalización o irritación meningea.
Evolucionado favorablemente Recibiendo tto atb ceftriaxonael dia de hoy 15.7.24 (4 /5)
Exámenes de laboratorio control : NT-proBNP : 22.667, V.H.S. : 34, leucocitos : 9,10 mil/ul Recuento Hematies : 3,89 * Mill/ul, hematocrito : 33,6 o/o, Hemoglobina : 11,4 g/dl, Plaquetas : 265 Sodio (Na) : 138,00 mmol/L, Potasio (K) : 3,40 * mmol/L , Cloro (Cl) : 103,00, Nitrógeno Ureico : 43 mg/dL Uremia : 91 , Proteina C Reactiva : 58,3, Albumina : 3,3 * g/dL, Creatinina : 1,50 mg/dl Calcio : 7,9 mg/dL LDH : 388 U/L Clearence Calculado(MDRD) : 32,34.
Sin requerimiento de oxígeno, normocardica, normotensa, normohidratada.
piel y mucosa hidratada, Tórax hipoexpansible mp presente con crepitos disperso, en base.rr2ts
Abdomen globoso, blando rha presente sin masa plable no doloroso. EEII edema +
Neurológico vigil orientado glagsow1 5 ptos sin focalización Neurológica. En Condiciones De Continuar Manejo Por HODO.

PLAN DE MANEJO:

Rescatar Panel viral
Ecocardiograma Ambulatorio
IC Cardiología
Acudir a urgencia sos signo de Alarma

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen hiposódico leve a tolerancia | Restricción hidrica 800cc/día
3. Amoxicilina 875 mg/ Acido Clavulánico 125 mg caeda 12 horas por 7 dias vo
4. Omeprazol 20mg vo día
5. Furosemida 20mg vo cada 12 horas
6. Carvedilol 3.125mg vo día
7. Aspirina 100mg vo día
8. Atorvastatina 80mg vo día
9. Paracetamol 1gr vo c8h SOS
10. B ipratropio 4 puff cada 6h
11. HGT + IC según esquema
12. KNT R + M

EXÁMENES Y RESULTADOS

Exámenes de laboratorio 15.7.24: NT-proBNP : 22.667, V.H.S. : 34, leucocitos : 9,10 mil/ul Recuento Hematies : 3,89 * Mill/ul
Hematocrito : 33,6 o/o, Hemoglobina : 11,4 g/dl, Plaquetas : 265 Sodio (Na) : 138,00 mmol/L, Potasio (K) : 3,40 * mmol/L , Cloro (Cl) : 103,00,
Nitrógeno Ureico : 43 mg/dL Uremia : 91 , Proteina C Reactiva : 58,3, Albumina : 3,3 * g/dL, Creatinina : 1,50 mg/dl Calcio : 7,9 mg/dL
LDH : 388 U/L Clearence Calculado(MDRD) : 32,34.

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO